

ITEM 158 : INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE

GONOCOQUE

Neisseria gonorrhoeae = **diplocoque Gram négatif**, non capsulé, cytochrome oxydase positif, immobile et asporulé, notamment retrouvé dans les **PNN**, **intracellulaire** ou **extracellulaire**, de transmission presque toujours sexuelle

- Incidence en ↗, prédominance masculine, âge moyen = 30 ans (homme), 20 ans (femme), plus fréquente en Ile-de-France
- Principaux sites d'infection : **urètre** chez l'homme, **col** et **vagin** chez la femme, possiblement **oropharyngé** (notamment chez le patient homo- ou bisexuel avec rapports oro-génitaux non protégés)

Diagnostic	- Période d'incubation courte = 2 à 7 jours			
	Infection non compliquée chez l'homme	Urétrite antérieure aiguë	= 10% des urétrites : tableau clinique le plus souvent bruyant - Écoulement urétral purulent (90% des cas) - Dysurie, douleurs urétrales à types de brûlures permanentes ou mictionnelles - Prurit urétral - Méatite , voire balanite - Bio : > 5 PNN au frottis urétral ou > 10 PNN à l'examen du 1^{er} jet urinaire	
		Anorectite	= Prédominante chez l'homme, asymptomatique dans 2/3 des cas, ou : prurit anal, anite, écoulement rectal permanent, diarrhée, saignement anorectal, syndrome rectal (ténosme, épreinte), sensation de défécation incomplète	
		Oro-pharyngite	- Le plus souvent asymptomatique - Portage souvent persistant après antibiothérapie (mauvaise diffusion)	
	Infection non compliquée chez la femme	- Asymptomatique dans 70% des cas - Cervicite : - Leucorrhées purulentes, pesanteur pelvienne et/ou signes d'urétrites associés - A l'examen : col non ou peu inflammatoire, écoulement purulent à l'orifice cervical		
	Complication	- Chez l'homme : prostatite, orchi-épididymite - Chez la femme : - Endométrite, salpingite (rare) - 2 ^{ndr} (rare) : algies pelviennes inflammatoires, stérilité tubaire, GEU - Septicémie : - Cutanée : purpura pétéchial, papules/papulo-pustules acrales/péri-articulaires - Articulaire : mono ou oligoarthritis septique, ténosynovite - Plus rarement : conjonctivite, endocardite, méningite		
Bio	- Urétrite : - Prélèvement bactériologique d'un écoulement urétral spontané (majorité) - Sans écoulement: - Sur 1^{er} jet d'urine (> 2h après dernière miction) - Prélèvement endo-urétral à l'écouvillon (jusqu'à 4 cm dans l'urètre), rarement fait - Prélèvement pharyngé, anal et cervico-vaginal : systématique chez la femme ou l'homosexuel masculin			
	Examen direct	= Diplocoque Gram négatif en « grains de café », intracellulaires - Bonne Se/Sp (95%) sur prélèvement d'écoulement urétral dans l'urétrite masculine symptomatique - Sensibilité plus faible sur prélèvement pharyngé, anorectal et cervico-vaginal : PCR possible		
	Culture	= Sur gélose au sang cuit (« chocolat ») = systématique : confirmation diagnostique, antibiogramme		
	→ Pas de sérologie gonococcique			
TTT	- Identification du/des partenaire(s) : dépistage, diagnostic ou traitement probabiliste - Recherche d'autres IST : sérologie VIH, VHB, TPHA-VDRL - Eviter les relations sexuelles pendant > 7 jours , et jusqu'à ce que le traitement soit pris et le(s) partenaire(s) traité(s) - Contrôle clinique à J7 : tolérance, efficacité, adaptation de l'antibiothérapie à l'antibiogramme - Contrôle bactériologique à J7 : si infection pharyngée non traitée par ceftriaxone ou apparition de signes cliniques			
	Antibiothérapie	Infection non compliquée	1 ^{ère} intention	- C3G dose unique : - Ceftriaxone 500 mg IM - Céfixime 400 mg po si refus d'injection (↘ efficacité)
			2 nd intention	- Dose unique de spectinomycine 2 g IM (si pharynx sain seulement)
			→ Traitement systématiquement d'une infection à <i>Chlamydia</i> en cas d'urétrite (associée dans 15% des cas) : azithromycine 1 g oral (dose unique) ou doxycycline oral (7 jours)	
		Infection génitale	- Orchi-épididymite : ceftriaxone 500 mg IM (unique) ou céfixime 800 mg (unique) - Endométrite, salpingite : ceftriaxone 1 g/j IV pendant 14 jours	
		Septicémie	- Ceftriaxone IV 1 à 2 g/j pendant 7 à 10 jours (septicémie) ou 10 à 14 jours (méningite) ou 4 semaines (endocardite)	

CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Chlamydia trachomatis = germe intracellulaire obligatoire, immobile

- Plusieurs sérotypes : - **Sérotypes D à K** (transmissibles par contact direct) : **infections urogénitales**

- **Sérotypes L1-L2-L3** : **lymphogranulomatose vénérienne**, ou **maladie de Nicolas-Favre**

- 1^{ère} maladie bactérienne sexuellement transmissible dans les pays industrialisés (2-10% des adultes jeunes) : plus fréquente chez les femmes de classes sociales défavorisées, jeune, avec de nombreux partenaires

- **Dépistage systématique** par **auto-prélèvement vaginal** chez les femmes jeunes < 25 ans recommandé en France

Diagnostic	C	- Portage asymptomatique très fréquent = 50% des cas chez l'homme et 50 à 90% des cas chez la femme : maintien de la transmission (surtout chez l'homme), survenue de complications tardives (surtout chez la femme) - Incubation longue : plusieurs semaines	
		Infection non compliquée	- Urétrite subaiguë (manifestation la plus fréquente chez l'homme) : écoulement urétral (50%), généralement clair, modéré et intermittent - Cervicite (manifestation la plus fréquente chez la femme) : généralement asymptomatique , ou leucorrhées blanchâtres/jaunâtres, cystalgies, syndrome urétral, dyspareunie , avec à l'examen une fragilité du col utérin , des sécrétions muco-purulentes , un ectropion friable hémorragique - Pharyngite et anorectite : rarement symptomatique
		Complication	- Homme : prostatite, épididymite aiguë - Femme : - Endométrite, salpingite : le plus souvent subaiguë ou chronique - 2 nd : algies pelviennes inflammatoires, stérilité tubaire (1 ^{ère} cause), GEU - Rarement péri-hépatite = syndrome de Fitz-Hugh-Curtis - Syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter : polyarthrite aiguë/subaiguë réactionnelle, urétrite, conjonctivite bilatérale, balanite circinée, kératodermie palmo-plantaire psoriasiforme - Autres : kérato-conjonctivite, arthrite - Nouveau-né (infection urogénitale maternelle) : kérato-conjonctivite, pneumopathie
	Bio	Prélèvements bactériologiques : - Homme symptomatique ou non : 1^{er} jet urinaire (10-20 mL) au moins 2h après la dernière miction - Femme symptomatique : écouvillonnage d'endocol et péri-urétral , avec raclage de la muqueuse - Femme asymptomatique : auto-prélèvement sur écouvillonnage vulvo-vaginal	
		PCR	= Examen clé du diagnostic : plus sensible que la culture
		Culture	= Sur milieu cellulaire : faible sensibilité, réservée aux laboratoires spécialisés, non réalisé en routine
		Sérologie	- Peu d'intérêt : ne distingue pas une infection active ou ancienne, négative en cas d'infection basse
	TTT	- Identification du/des partenaire(s) : dépistage, diagnostic ou traitement probabiliste - Rechercher d'autres IST : sérologie VIH, VHB, THPA-VDRL - Dépistage par auto-prélèvement (chez la femme) ou 1 ^{er} jet d'urine (dans les 2 sexes) : essentiel chez tous les partenaires, même asymptomatiques - Eviter les rapports sexuels non protégés pendant la période du traitement - Surveillance : PCR systématique à 3-6 mois chez la femme jeune (ou à 1 mois si enceinte)	
		Infection non compliquée	1 ^{ère} intention - Azithromycine : 1 g par voie orale en dose unique - Doxycycline : 100 mg/12h par voie orale pendant 7 jours
			2 nd intention - Erythromycine : 500 mg/6h par voie orale pendant 7 jours - Ofloxacin : 300 mg/12h par voie orale pendant 7 jours
		Infection génitale	- Orchi-épididymite : doxycycline (100 mg/12h) pendant 10 jours - Endométrite, salpingite : doxycycline (100 mg/12h) orale ou IV pendant 14 jours → En cas de doute : une sérologie positive est témoin d'une infection génitale haute
		Nouveau-né	- Pneumopathie, ophtalmie : érythromycine (12,5 mg/kg/6h) <i>po</i> ou IV pendant 14 jours

SYPHILIS

Due à ***Treponema pallidum*** = **spirochète** (bactérie hélicoïdale Gram négatif) : IST non immunisante, très contagieuse

- Contagiosité des lésions muqueuses uniquement (chancre et syphilide érosive) : transmission surtout **sexuelle** (après rapport non protégé, dont oro-génital), rarement **materno-fœtale** (4-5 mois de grossesse), **post-transfusionnelle** ou **greffe d'organe**
- En recrudescence depuis quelques années en France, surtout chez l'homosexuel masculin, VIH
- **Dépistage sérologique** : sujet à risque (homo-, bi- ou hétérosexuel à partenaires multiples) et patient VIH

Stade

- **Syphilis précoce < 1 an** = syphilis primaire, syphilis secondaire ou syphilis latente précoce (sans lésion clinique)
- **Syphilis tardive > 1 an ou non datable** = syphilis tertiaire ou syphilis latente tardive
- La syphilis primaire est souvent méconnu lorsque le chancre n'est pas visible (vaginal, col utérin, anorectal, pharyngé)
- La syphilis secondaire n'est pas toujours évoquée du fait du polymorphisme des lésions cliniques

SYPHILIS PRIMAIRE

= Incubation de **3 semaines** en moyenne (10 à 90 jours) : chancre (contagieux) et ADP satellite

Chancre syphilitique		= Exulcération ou érosion, plus rarement ulcération muqueuse : - De 5 à 15 mm de diamètre, unique, plus rarement multiple - Indolore (≠ herpès) - Fond propre, rosé - Induré = très évocateur : impossibilité de plisser entre les doigts la surface de l'ulcération → Aucune caractéristique pathognomonique : à évoquer devant toute ulcération muqueuse aiguë
	Siège	- Chez l'homme : sillon balano-préputial, plus rarement gland ou fourreau - Chez la femme : partie externe de la vulve (petites lèvres, grandes lèvres, fourchette), ou plus rarement vaginal (volontiers inaperçu) - Dans les 2 sexes : muqueuse buccale ou pharyngée (fellation), muqueuse anorectale
ADP satellite	- ADP satellite : non inflammatoire, le plus souvent unilatéral, généralement inguinale - Non repérable cliniquement dans certaines localisations : col utérin, rectum	
Evolution	- Régression spontanée sans séquelle en quelques semaines - Evolution vers les stades tardifs : - 30% de syphilis secondaire - Syphilis tardive (possiblement sans signe de syphilis secondaire)	

SYPHILIS SECONDAIRE

= **Diffusion systémique** du tréponème : poussées d'**éruptions cutanéomuqueuses** ± signes généraux et viscéraux, entrecoupées de phases asymptomatiques de quelques semaines/mois, sur une **durée généralement < 1 an**

- Débute généralement **6 semaines** après le chancre, possible jusqu'à **1 an** après contamination

Roséole syphilitique	= 1^{ère} éruption de la syphilis secondaire : souvent inaperçue car peu intense et transitoire (7-10 jours) - Macules roses pâles de 5 à 15 mm de diamètre, disséminées sur le tronc - Sans signe fonctionnel
Syphilide papuleuse	- Eruption polymorphe morbiliforme - Lésion élémentaire = papule : - Cuivrée - Fine desquamation péri-lésionnelle = collerette de Bielt : inconstante mais très évocatrice - Localisée au visage, au tronc et/ou aux membres - En nombre variable (de quelques unes à plusieurs centaines) - Pouvant revêtir un aspect nécrotique, croûteux ou ulcéré → Contagieuse si ulcérée
Syphilide palmo-plantaire	= Très évocatrice : siège électivement à cheval sur les plis palmaires - Inconstante (30% des syphilis secondaires), souvent discrètes → Leur constatation suffit à évoquer le diagnostic, mais leur absence n'élimine pas le diagnostic
Syphilide génitale et périnéale	- Généralement papules ou érosions multiples, molles, indolores, non prurigineuses - Recherche de tréponème au microscope à fond noir souvent positive en cas de lésions érosives → Erosions très contagieuses
Symptômes cutanéophanériens trompeurs	- Fausse perlèche : papule commissurale fendue en 2 (et non simple fissure sans relief) - Lésions d'allure séborrhéique des sillons naso-géniens - Papules acnéiformes du menton - Décapillation en aires de la langue (plaques « fauchées ») - Dépilation des sourcils - Alopécie : plusieurs aires complètement dépilées sur un cuir chevelu sain (« en fourrure mitée »)

SYPHILIS SECONDAIRE	Signes généraux	= Dissémination de l'infection : le plus souvent discrets, possiblement sévères - Fièvre , le plus souvent de 38 à 38,5°C, pouvant atteindre 39,5°C - Altération variable de l'état général - Céphalées (≠ atteinte neuro-méningée, souvent 2 ^{ndr} à des micro-abcès périostés) - Syndrome méningé - Raucité de la voix - Polyadénopathies - Hépatosplénomégalie (avec hépatite biologique cytolytique ou cholestatique) - Polyarthralgie - Douleurs lancinantes « osseuses »...			
	Neuro-syphilis précoce	= Atteinte neurologique au cours de la syphilis secondaire : PL , traitement par pénicilline G x 14 jours - Manifestations ophtalmiques : uvéite antérieure ++ , uvéite postérieure , papillite , névrite - Atteinte d'une paire crânienne (neurosyphilis précoce) : hypoacousie , paralysie faciale... - Méningite			
SYPHILIS TERTIAIRE		= Très rare actuellement : granulomatose avec atteintes viscérales multiples - Neurologique = neurosyphilis tardive : tabès , démence - Autres : vasculaire (aortite), osseuse (périostite), cutanéomuqueuse (gomme)...			
Diagnostic biologique	→ Le tréponème ne se cultive pas <i>in vitro</i> : aucune culture possible, aucun antibiogramme				
	Microscope à fond noir	- Pratiqué sur des lésions érosives : chancre d'inoculation ou syphilide érosive muqueuse - Sensibilité : 50% au niveau du chancre, sans valeur au niveau buccal (spirochètes saprophytes)			
	Diagnostic sérologique	= Examen standardisé, peu coûteux, fiable : généralement seulement TPHA-VDRL - Ne différencie pas une syphilis et une tréponématose endémique non vénérienne (pian, béjel, pinta)			
		TPHA	= Treponema pallidum Haemagglutination Assay : réaction spécifique des tréponématoses - Positive autour du 8 à 10^{ème} jour du chancre, avant le VDRL - Intensité cotée en dilution (1/80, 1/160...) : le titre du TPHA quantitatif n'est pas un bon marqueur de l'évolutivité ou de la réponse au traitement (variation inter-examen) - Se négative si le traitement est instauré pendant l'année suivant le chancre (syphilis précoce)		
		VDRL	= Veneral Disease Research Laboratory : mise en évidence d'Ac anti-cardiolipides - Non spécifique des tréponématoses : maladie dysimmunitaire , notamment lupus et SAPL , maladie infectieuse à Mycoplasma pneumoniae ou borréliose - Positive autour du 8 à 10^{ème} jour du chancre , puis ↗ pour atteindre un plateau en 3 à 6 mois durant la phase secondaire (entre 16U et 128U) - Surveillance de l'efficacité du traitement : titre quantitatif du VDRL divisé par 4 à 6 mois - Recontamination syphilitique : remontée significative du VDRL quantitatif (multiplié par ≥ 4)		
		FTA	= Peu utilisé : syphilis très précoce ou nouveau-né		
		Interprétation	TPHA -	VDRL -	- Absence de tréponématose - Tréponématose très récente (incubation ou 5 à 15 jours du chancre) - Tréponématose guérie traitée précocement
			TPHA +	VDRL +	- Tréponématose traitée ou non, guérie ou non
	TPHA -		VDRL +	Faux positif : - Infection : tuberculose, pneumocoque, leptospirose, borréliose, VIH, varicelle, oreillons, MNI, hépatite, rougeole, paludisme... - Non infectieuse : grossesse, toxicomanie IV, hépatopathie chronique, gammopathie monoclonale, lupus, SAPL, cancer	
	TPHA +		VDRL -	- Tréponématose guérie - Tréponématose très précoce (1 ^{ers} jours du chancre) - Syphilis tertiaire très ancienne (rare) - Fausse positivité du TPHA (exceptionnelle) : maladie de Lyme, lupus	
DD	D'une syphilis primaire	- Herpès : ulcération superficielle, douloureuse, à contours polycycliques - Chancre mou : terrain (Africain), lésions multiples, fond sale, très douloureuses, ADP inflammatoire - Donovanose : terrain (Africain), lésions peu douloureuses granulomateuses - Maladie de Nicolas-Favre (lymphogranulomatose vénérienne) : terrain (Africain, homosexuel), anorectite, ulcérations ano-génitales, diarrhées trompeuses			
	D'une syphilis secondaire	- Eruption roséoliforme : virose, toxidermie (exanthème maculeux) - Au visage : dermatite séborrhéique , acné , psoriasis - Lésions papuleuses : psoriasis , lichen plan , eczéma			

TTT	- Recherche d'autres IST : dépistage gonocoque/Chlamydia, sérologie VIH (associé dans 10% des cas), hépatite B - Examen ophtalmique systématique en cas de syphilis secondaire - Contacter un spécialiste en cas de situation particulière : femme enceinte, sujet VIH+, allergie à la pénicilline - Traitement d'emblée en cas d'ulcération génitale, sans attendre les résultats du TPHA-VDRL		
	TTT de la syphilis précoce	En 1 ^{ère} intention	- Benzathine-benzylpénicilline G (Extencilline®) : 2,4 millions d'UI en 1 injection IM unique
		Réaction d'Herxheimer	- Syphilis primaire : sans gravité - Syphilis 2^{ndr} : fièvre, céphalée, myalgie, accentuation des signes locaux quelques heures après injection → toujours bénigne
		En 2 nd intention	= Allergie à la pénicilline : doxycycline par voie orale 100 mg 2 fois/j pendant 14 jours - Contre-indiqué chez la femme enceinte ou le patient VIH+ → avis spécialisé
	Autres formes	Syphilis tardive	- Extencilline® IM en 3 injections à 1 semaine d'intervalle
		Neurosyphilis	- Pénicilline G par voie IV (non retard) pendant 14 jours - En cas d'allergie : doxycycline non indiqué → avis spécialisé (induction de tolérance)
	Suivi	- Contrôle de l'efficacité à 6, 12 et 24 mois : clinique, sérologie TPHA-VDRL quantitatif (doit être divisé/4) - VDRL : doit être négatif 1 an après le traitement d'une syphilis primaire et 2 ans après une syphilis 2^{ndr} → Si aucune diminution significative : - 3 injections d'Extencilline 2,4 millions d'UI à 8 jours d'intervalle - Avis d'un spécialiste	
	Sujet contact sexuel	- Examen clinique et sérologie chez tous les sujets contacts sexuels - Si contact récent (< 1 mois) : sérologie possiblement faussement négative - Traitement systématique possible par 1 injection d'Extencilline® 2,4 millions d'unité	
	Cas particuliers	Femme enceinte	→ Risque de syphilis congénitale à partir du 4-5^{ème} mois de grossesse - TTT identique au cas général selon le stade précoce ou tardif ± Corticoïdes pendant 4 jours en prévention de la réaction d'Herxheimer - Suivi clinique et biologique 1 fois/mois - Suivi échographique essentielle : signe de foetopathie - En cas d'allergie à la pénicilline : induction de tolérance à la pénicilline après avis spécialisé
		Sujet VIH+	- Traitement standard par pénicilline identique au cas général - En cas d'allergie à la pénicilline : cycline contre-indiqués - En cas de pratique à risque : sérologie syphilis au moins 1 fois/an

TRICHOMONOSE			
Trichomonas vaginalis : IST due à un protozoaire flagellé, anaérobie, dont le réservoir naturel est le vagin - Transmission presque exclusivement sexuelle, en milieu humide			
Diagnostic	C		- Incubation : 2 semaine
		Chez l'homme	- Généralement asymptomatique - Urétrite , le plus souvent subaiguë - Balano-posthite - Ecoulement urétral matinal, prurit
		Chez la femme	- Asymptomatique dans 20% des cas - Vaginite ou cervico-vaginite - Prurit intense , associé à une dyspareunie ou des signes urinaires - Leucorrhée abondante , verdâtre, spumeuse et malodorante - Vulve oedématisée, colpite punctiforme à l'examen du col
	PC	- Prélèvement du cul-de-sac vaginal postérieur chez la femme ou de l'urètre antérieur chez l'homme : examen direct à l'état frais ± coloration spéciale, mise en culture	
PEC	- Examen et dépistage du/des partenaire(s) - Proposer un dépistage des IST : sérologie VIH, TPHA-VDRL, sérologie VHB, PCR Chlamydia trachomatis - Rapport sexuel protégé pendant la période de traitement		
TTT	- Métronidazole : 2 g en dose unique ou 500 mg x 2/j pendant 7 jours - Nimorazole : 2 g en dose unique - Secnidazole : 2 g en dose unique		

INFECTION GENITALE A HPV

Condylome = verrue génitale : infection génitale à **papillomavirus humain**

- Prédominant chez les jeunes de 16 à 25 ans : prévalence de 5% < 25 ans → plus fréquente des IST
- **Transmission sexuelle** dans les mois suivant le 1^{er} rapport sexuel :
 - **Élimination du virus** dans la majorité des cas (90%)
 - **Portage asymptomatique** dans 10% des cas
 - **Lésion à HPV** dans 1% des cas
- Transmission non sexuelle possible :
 - **Contact avec des linges humides contaminés**
 - **Lors de l'accouchement** : risque de **papillomatose laryngée juvénile**
- **HPV à bas risque (6 et 11)** : 90% des condylomes

Diagnostic	C	- Examen clinique complet des régions anales et génitales, complété par une colposcopie ou péniscope		
		Aspect clinique habituel	- Condylome acuminé = « crête de coq » : masse charnue, hérissée de petites verrucosités kératosiques, de 0,2 à 1 cm, plus ou moins profuses, de quelques unes à plusieurs dizaines - Condylome plan : macule isolée ou en nappes ou mosaïques, de couleur rosée, parfois invisible à l'œil nu et révélée par l'application d'acide acétique - Néoplasie intra-épithéliale = lésion précancéreuse cutanée ou muqueuse : cervicale (CIN), vulvaire (VIN), anale (AIN) ou pénienne (PIN), associée aux HPV oncogènes 16 et 18	
		Aspect particulier	- Condylome géant de Buschke-Loewenstein (forme rare) : aspect tumoral, cliniquement inquiétant mais bénin, associé à HPV 6 et 11 - Papulose bowénoïde (chez l'adulte jeune) : multiples lésions papuleuses isolées ou confluentes, de couleur rose ou brunâtre, à surface lisse ou mamelonnée, parfois squameuse ou kératosique, associée à HPV16 et 18, d'évolution chronique	
		Situation particulière	Chez la femme	- Condylome vulvaire : grandes ou petites lèvres, clitoris et vestibule - Forme étendue : vagin, périnée, région péri-anale
			Chez l'homme	- Siège de prédilection : face interne du prépuce, sillon et frein balano-préputial - Autre localisation : gland, fourreau de la verge, méat urétral
	Chez l'enfant		- Le plus souvent par contamination manuportée à partir de verrue vulgaire ou à partir du linge domestique - Discuter un risque de sérvices sexuels	
DD	- Hyperplasie physiologique des papilles de la couronne du gland - Papillomatose vestibulaire vulvaire physiologique - Syphilide secondaire - Carcinome <i>in situ</i>			
TTT	- Objectif : éradication des lésions macroscopiquement visibles (aucun traitement spécifique d'HPV) → 30% de récive - Rassurer le patient : n'est pas indicatif d'un comportement à risque sexuel - Suivi évolutif des lésions à 1 mois, 3 mois puis jusqu'à guérison clinique - Examen du/des partenaire(s) nécessaire - Recherche d'IST associée : sérologie VIH, TPHA-VDRL, VHB, PCR <i>Chlamydia</i> urinaire ou auto-prélèvement vaginal - Dépistage systématique des lésions du col : frottis cervical			
	TTT préventif	- Vaccin à base de <i>virus-like particles</i> , remboursé à 65% = bivalent (16,18) ou tétravalent (6,11,16,18) : proposé aux jeunes filles de 11 à 14 ans, ou rattrapage vaccinal de 15 à 19 ans, en 3 doses (M0, M2, M6) - Rapport sexuel protégé (transmission possible même avec usage de préservatifs)		
	TTT curatif	- Cryothérapie : application d'azote liquide avec un coton-tige, douloureux - Laser CO2 : très douloureuse, le plus souvent sous anesthésie générale, risque de cicatrice - Electrocoagulation : sous AL, permet la destruction des lésions ou le prélèvement pour analyse histo - Podophyllotoxine 5% (Condyliline®, Wartec®) : résine naturelle, appliquée matin et soir pendant 3 jours consécutifs/semaine jusqu'à guérison, contre-indiqué chez la femme enceinte et l'enfant - Imiquimod (Aladara®) : immunomodulateur, application 3 fois/semaine pendant 4 mois		
	Chez la femme enceinte	- Condylomes plus exubérants lors de la grossesse - Transmission materno-fœtale lors de l'accouchement : papillomatose laryngée de l'enfant - Traitement des condylomes au début du 3 ^{ème} trimestre, au laser CO2 (± renouvelé)		